

სიმსივნე და ფსიქოლოგიური სტრესი

ქეთევან ჯაფარიძე
სტუ-ს დოქტორანტი

რეზიუმე

ფსიქოლოგიური სტრესი აღწერს, თუ რას გრძნობს ადამიანი, როდესაც ის არის გონებრივი, ფიზიკური თუ ემოციური წნეხის ქვეშ. მიუხედავად იმისა, რომ ნორმალურია დროდადრო გარკვეული ფსიქოლოგიური სტრესის განცდა, იმ ადამიანებს, რომლებიც განიცდიან მაღალი დონის ფსიქოლოგიურ სტრესს ან ვინც სისტემატიურად ექცევა სტრესის ქვეშ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში, შეიძლება დაეწყოთ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები (მენტალური ან/და ფიზიკური).

სტრესი შეიძლება გამოწვეული იყოს როგორც ყოველდღიური მოვალეობებითა და რუტინულ მოვლენათა მსვლელობით, ასევე უფრო უჩვეულო მოვლენებითაც, როგორიცაა საკუთარი, ან ახლო ოჯახის წევრის ტრავმა ან ავადმყოფობა. როდესაც ადამიანი გრძნობს, რომ უძლურია გაუმკლავდეს, ან მართოს კიბოთი გამოწვეული ცვლილებები, ან ჩვეულებრივი ცხოვრებისეული აქტივობები, ისინი ვარდებიან მწუხარებაში. მწუხარებას სულ უფრო ხშირად მიიჩნევენ ცხოვრების ხარისხის გაუარესების გამომწვევ ფაქტორად სიმსივნით. დაავადებულ პაციენტებში.

საკვანძო სიტყვები: სტრესი, ფსიქოლოგიური ტრავმა, ოჯახი, პაციენტები

PSYCHOLOGICAL STRESS

Ketevan Japaridze
PhD student of GTU

RESUME

Psychological stress describes how a person feels when they are under mental, physical or emotional pressure. Although it is normal to experience some psychological stress from time to time, people who experience high levels of psychological stress or who are systematically stressed for long periods of time may start to experience health problems (mental and/or physical).

Stress can be caused by daily duties and routine events, as well as by more unusual events, such as injury or illness of oneself or a close family member. When a person feels powerless to cope with or manage the changes caused by cancer, or the normal activities of life, they fall into grief. Grief is increasingly recognized as a contributing factor to poor quality of life in cancer patients.

Keywords:; Stress, psychological, trauma, family.

ძირითადი ნაწილი

არსებობს გარკვეული საფუძველიც კი ვარაუდისთვის, რომ ღრმა დეპრესიასთან არის დაკავშირებული მკურნალობის ცუდი შედეგები. ექიმებისა და ექთნებისათვის შექმნილია სამკურნალო გაიდლაინები, რომლებიც მათ ეხმარება პაციენტებში დეპრესიის დონის შეფასებასა და დეპრესიის მართვის ხელშეწყობაში.

მოცემული საინფორმაციო ბიულეტენი გვანდის ზოგად შესავალ მიმოხილვას იმ სტრესის შესახებ, რომელსაც განიცდიან ადამიანები კიბოსთან ბრძოლის დროს. უფრო დანვრილებითი ინფორმაცია სტრესით გამოწვეულ სპეციფიურ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მოიძიოთ საინფორმაციო ბიულეტენის ბოლოში დართულ „დაკავშირებულ წყაროებსა“ და „შერჩეულ მითითებებში“.

როგორი არის ორგანიზმის საპასუხო რეაქცია სტრესის დროს?

ფიზიკური, გონებრივი, თუ ემოციური წნეხის საპასუხოდ ორგანიზმი გამოჰყოფს სტრესულ ჰორმონებს (როგორიცაა ეპინეფრინი და ნორეპინეფრინი), რომლებიც თავის მხრივ უმატებს არტერიულ წნევას, აჩქარებს გულისცემას და ზრდის სისხლში შაქრის დონეს. ეს ცვლილებები ეხმარება ადამიანს იმოქმედოს უფრო ენერგიულად და სწრაფად აღქმული საფრთხის თავიდან ასაცილებლად.

კვლევამ აჩვენა, რომ მათ, ვინც ინტენსიური და ხანგრძლივი (ე.ი. ქრონიკული) სტრესის ქვეშ არიან, შეიძლება დაეწყოთ მომენლებელ და რეპროდუქციულ სისტემებთან, საშარდე გზებთან, ასევე დაქვეითებულ იმუნურ სისტემასთან დაკავშირებული პრობლემები. ქრონიკული სტრესის ქვეშ მყოფი ადამიანები უფრო მონყვლადნიც არიან ვირუსული ინფექციების მიმართ, როგორც არის გრიპი ან უბრალოდ გაციება, ასევე თავის ტკივილების, უძილობის, დეპრესიის და შფოთვის მიმართ.

მიუხედავად იმისა, რომ სტრესი იწვევს ფიზიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ უამრავ პრობლემას, მტკიცებულებები, რომ მას შეუძლია გამოიწვიოს კიბო, ძალიან სუსტია. მართალია, ზოგიერთი კვლევა მიუთითებს სხვადასხვა ფსიქოლოგიური ფაქტორის კავშირზე კიბოს განვითარების გაზრდილ რისკთან, მაგრამ სხვა კვლევები ამას არ ადასტურებენ.

ამჟამად კავშირი ფსიქოლოგიურ სტრესსა და კი-

ბოს შორის შეიძლება რამდენიმე სახით გამოვლინდეს. მაგალითად, სტრესის ქვეშ მყოფმა ადამიანმა შეიძლება ისეთი მავნე ქცევა შეიძინოს, როგორიცაა მონევა, ან ჭარბი კვება, ან ალკოჰოლის მიღება, რაც თავის მხრივ ზრდის კიბოს განვითარების რისკს. თუმცა პიროვნებას, რომელსაც ჰყავს კიბოთი დაავადებული ნათესავი, შეიძლება გააჩნდეს კიბოს განვითარების უფრო მაღალი რისკი არა იმიტომ, რომ ოჯახის წევრის დიაგნოზით მიღებული სტრესისგანაა ეს გამომწვეული, არამედ საზიარო მემკვიდრეობითი რისკფაქტორების გამო.

როგორ მოქმედებს ფსიქოლოგიური სტრესი ადამიანებზე, რომლებსაც აქვთ კიბო?

ადამიანებისათვის, რომლებსაც აქვთ კიბო, ამ დაავადებით გამომწვეული ფიზიკური, ემოციური და სოციალური ეფექტები, შეიძლება იყოს სტრესული. მათ, ვინც სტრესის მართვას ცდილობს საფრთხის შემცველი ქცევებით, როგორიცაა მონევა ან ალკოჰოლის მიღება, ან ვინც უფრო უმოქმედო ხდება, შეიძლება გაუუარესდეთ ცხოვრების ხარისხი კიბოს მკურნალობის შემდეგ. ამის საპირისპიროდ, ისინი, ვინც იყენებენ ეფექტურ სტრატეგიებს სტრესთან გასამკლავებლად, როგორიც არის რელაქსაცია და სტრესის მართვის ტექნიკები, ავლენენ უფრო დაბალი ხარისხით დეპრესიას, შფოთვისა და კიბოსა და მის მკურნალობასთან დაკავშირებულ სიმპტომებს. თუმცა, არანაირი დასაბუთება იმისა, რომ ფსიქოლოგიური სტრესის წარმატებული მართვა ზრდის კიბოსგან განკურნების შანსებს, არ არსებობს.

ექსპერიმენტული კვლევებიდან მიღებული შედეგები იძლევა ვარაუდის მყარ საფუძველს, რომ ფსიქოლოგიურ სტრესს შეუძლია იმოქმედოს სიმსივნის ზრდისა და გავრცელების უნარზე. მაგალითად, ზოგიერთმა კვლევამ აჩვენა, რომ ადამიანის სიმსივნით დაავადებული თავგები როდესაც იყვნენ შეზღუდულ სივრცეში ან იზოლირებულები სხვა თავგებისგან - მდგომარეობაში, რომელიც ზრდის სტრესს - სიმსივნე მათ ორგანიზმში უფრო დიდი ალბათობით იზრდებოდა და ვრცელდებოდა (მეტასტაზირდებოდა). ექსპერიმენტების ერთ ნაკრებში, თავგების სარძევე ცხიმის ბალიშებში გადანერგილი სიმსივნე უფრო ინტენსიურად ვრცელდებოდა ფილტვებსა და ლიმფურ კვანძებში, როდესაც თავგები იმყოფებოდნენ ქრონიკული სტრესის ქვეშ, იმ თავგებთან შედარებით, რომლებზეც არ იყო გამოყენებული სტრესფაქტორები. ლაბორატორიაში გამოზრდილი თავგისა და ადამიანის კიბოს უჯრედების შესწავლამ ცხადყო, რომ სტრესის ჰორმონმა ნორეპინეფრინმა, რომელიც მონაწილეობს ორგანიზმის „ბრძოლა-თუ-გაქცევა“ საპასუხო რეაქციაში, შეიძლება

ხელი შეუწყოს ანგიოგენეზსა და მეტასტაზების განვითარებას.

მეორე კვლევის ფარგლებში გამოიკითხნენ ქალები სამმაგი უარყოფითი სარძევე ჯირკვლის კიბოთი, რომლებმაც გაიარეს ნეოადიუვანტური ქიმიოთერაპია, იყენებდნენ თუ არა ისინი ბეტა ბლოკატორებს - მედიკამენტებს, რომლებიც ხელს უშლის სტრესის გარკვეული ჰორმონების წარმოქმნას - ქიმიოთერაპიის დროს და მანამდე. იმ ქალებს, რომლებიც გამოიკითხვის თანახმად იყენებდნენ ბეტა ბლოკატორებს, კიბოს მკურნალობის დროს გადარჩენის მეტი შანსი ჰქონდათ რეციდივის გარეშე, იმ ქალებთან შედარებით, რომლებიც გამოიკითხვის თანახმად არ იყენებდნენ აღნიშნულ პრეპარატს. თუმცა, საერთო გადარჩენის თვალსაზრისით ჯგუფებს შორის განსხვავება არ ყოფილა.

ამრიგად, ჯერ კიდევ არ არსებობს ძლიერი მტკიცებულება იმისა, რომ სტრესი პირდაპირ გავლენას ახდენს კიბოს შედეგებზე, თუმცა ზოგიერთი მონაცემი იძლევა საფუძველს ვარაუდისთვის, რომ პაციენტებს შეიძლება განუვითარდეთ უმწეობის ან უიმედობის განცდა უკიდურესი სტრესის დროს. ეს პასუხი დაკავშირებულია სიკვდილის მაღალ მაჩვენებლებთან, თუმცა ამ შედეგის მექანიზმი გაურკვეველია. შესაძლოა, ადამიანები, რომლებიც თავს უმწეოდ ან უიმედოდ გრძნობენ, არ ცდილობენ მკურნალობას, როდესაც ავადდებიან, ნაადრევად ყრიან ფარ-ხმალს ან არასისტემატურები არიან პოტენციურად სასარგებლო თერაპიის მიღებისას, ანდა საფრთხის შემცველ ქცევებს იძენენ, როგორიცაა ნარკოტიკების მოხმარება, ან ვერ ინარჩუნებენ ჯანსაღი ცხოვრების წესს, რაც ნაადრევი სიკვდილით მთავრდება.

როგორ უნდა ისწავლონ კიბოთი დაავადებულებმა ფსიქოლოგიურ სტრესთან გამკლავება?

ემოციური და სოციალური მხარდაჭერა შეიძლება დაეხმაროს პაციენტებს ისწავლონ ფსიქოლოგიურ სტრესთან გამკლავება. ასეთ მხარდაჭერას შეუძლია შეამციროს დეპრესიის, შფოთვის და დაავადებასთან და მკურნალობასთან დაკავშირებული სიმპტომების დონე პაციენტებში. მიდგომები შეიძლება შეიცავდეს შემდეგს:

- ვარჯიში რელაქსაციაში, მედიტაციასა ან სტრესის მართვაში
- თერაპია კონსულტაციის ან საუბრის სახით
- კიბოს შესახებ ცოდნის გაღრმავების მიზნით სესიებზე დასწრება
- სოციალური მხარდაჭერა ჯგუფურ გარემოში განთავსებით
- მედიკამენტები დეპრესიის ან შფოთვისთვის
- ფიზიკური ვარჯიში

დასკვნა

ზოგიერთი საექსპერტო ორგანიზაცია გვიჩვენებს, რომ კიბოთი დაავადებული ყველა პაციენტი შემოწმდეს სტრესზე მკურნალობის დასაწყისშივე. ზოგი მათგანი ასევე გვიჩვენებს კრიტიკულ ეტაპებზე განმეორებით შემოწმებას მკურნალობის კურსის განმავლობაში. მედპერსონალს შეუძლია სტრესის შესამოწმებლად გამოიყენოს სხვადასხვა საშუალება, როგორცაა მაგალითად შფოთვის შკალა ან კითხვარი, რათა განსაზღვრონ, სჭირდებათ თუ არა კიბოთი დაავადებულ პაციენტებს დახმარება თავიანთი ემოციების მართვაში, ან სხვა პრაქტიკულ პრობლემებთან დაკავშირებით. პაციენტები, რომლებიც ამჟღავნებენ ზომიერიდან მძიმე ხარისხამდე შფოთვის, ჩვეულებრივ გადამისამართდებიან შესაბამის პირებთან, როგორცაა კლინიკის ჯანმრთელობის ფსიქოლოგი, სოციალური მუშაკი, სასულიერო პირი ან ფსიქიატრი.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. უზნაძე დ., „განწყობის ფსიქოლოგია“ - ექსპერიმენტული საფუძვლები, „ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის შრომები“, 1949. დ. უზნაძე - ზოგადი ფსიქოლოგია.
2. ირაკლი იმედაძე - „ფსიქოლოგიის საფუძვლები“
3. მარინა ბალიაშვილი - „სოციალური ფსიქოლოგიის საფუძვლები“- გამომცემლობა მნიგნობარი - თბილისი 2010წ.
4. კლინიკური ფსიქოლოგიის შესავალი. რედაქტირება. მაკ გრაუ ჰილი, მექსიკა.
5. ვიკიპედიის ფონდი. 2010 წ.
6. Knapp, E. (2005), ფსიქოლოგია და ჯანმრთელობა
7. კნაპ როდრიგესი, ელისა. ადამიანის ჯანმრთელობის ფიზიოლოგიური და ფსიქოლოგიური შუამავლები.